《肉芽肿性小叶性乳腺炎中医诊疗专家共识》征求意见汇总处理表

标准名称：肉芽肿性小叶性乳腺炎中医诊疗专家共识

负责起草单位：广东省中医院

牵头专家：刘晓雁、陈前军电话：81499399-8355 填写日期：__2022 年_3_月_11 日

序号	条款	提出意见专家	提出意见单位	意见内容	修改为	处理结果
1	2 规范性引用文件	杨丽华	厦门市中医院	（注日期的引用文件,）该处逗号为半角，应改为全角“，”。	改为全角	采纳 已更改。
2	3	胡金辉	湖南中医药大学第一附属医院	临床多表现为外周起病的疼痛性肿块		部分采纳 措词更为简洁。原文中为“短期内出现的疼痛性肿块，多外周起病，进展迅速”主要意在描述后期“可波及乳头乳晕后方”
3	3	霍艳丹	四川省第二中医医院	发热：本类患者发热常见下午、晚间发热，低热为主		部分采纳 本病患者确以下午晚间发热为主，也有其他时段的发热，共识书写中未做专列描述。
4	4	樊英怡	北京中医药大学第三附	流行病学特点：未提及疾病是单侧还		采纳 已做修订，在后续的预后及关于新发复发的概念

			属医院	是双侧发病		中有提及本病有对侧乳房发病的可能。
5	4	谢丹	广州中医药大学第一附属医院	在流行病学的章节，最好能有近年肉芽肿性乳腺炎的发病率数据		未采纳。 目前还没有关于ＧＬＭ大型数据的流行病学数据，需后待补充。
6	5	蒋孜明	玉林市中医医院	辨证：太阴传阳明痈脓，系在太阴。		未采纳 需后续临床进一步研究。本次专家共识在治疗领域，尤其是具体的治疗方药方面，从六经辨证或是脏腑辨证，暂未达成共识，需要进一步高水平的临床研究。
7	5	霍艳丹	四川省第二中医医院	乳痈范畴；乳痈隶属阳证，而本病并非起病均有阳证表现		部分采纳 共识中已有体现。本病属中医疮疡"乳痈“范畴，但为了与＂乳痈“所指代的“急性化脓性乳腺炎“相区别，本次专家咨询专家投票多数支持”肉芽肿性乳腺炎“的中医诊断。
8	5	赵虹	浙江中医药大学附属第一医院（浙江省中医院）	病机特点的描述，有待商榷		部分采纳 本次专家共识在病机领域的描述，暂未达成更多共识，需要进一步临床探讨研究
9	6.1	樊英怡	北京中医药大学第三附属医院	“可有乳房外伤史或劳累史”，可增加情绪波动史		采纳 已更改，在调摄部分体现为“饮食、情绪、外伤、过度劳累、妊娠/流产等”
10	6.1	霍艳丹	四川省第二中医医院	症见乳房肿胀，疼痛，时有红肿・・・	伴有肿块，或伴有皮肤潮红菲薄・・・	采纳
11	6.1	罗明	中山市中医院	建议将其命名为“慢性乳痈”		未采纳 本病属中医疮疡"乳痈“范畴，但为了与＂乳痈“所

						指代的“急性化脓性乳腺炎“相区别，本次专家咨询专家投票多数支持”肉芽肿性乳腺炎“的中医诊断。
12	6.1	张晓军	中国中医科学院西苑医院	专家建议将其命名为“肉芽肿性乳痈”	命名为“烂乳痈”	未采纳 需后续临床进一步研究，为了与疮疡中“乳痈”所指代的临床“急性化脓性乳腺炎“相区别，本次专家咨询专家投票多数支持”肉芽肿性乳腺炎“的中医诊断。
13	6.1	倪毅	南通市第三人民医院	粉刺性乳痈一般指浆细胞性乳腺炎	加入与“粉刺性乳痈”相区别。	采纳 共识中已有体现。共识中鉴别诊断将常见的非哺乳期乳腺炎进行临床鉴别，包含了浆细胞性乳腺炎（导管周围炎／粉刺性乳痈）
14	6.1	贾建东	天津中医药大学第一附属医院	中医诊断肉芽肿性乳痈是否贴切	可考虑“乳疽”诊断	未采纳 需后续临床进一步研究，为了与疮疡中“乳痈”所指代的临床“急性化脓性乳腺炎“相区别，本次专家咨询大多数专家投票支持”肉芽肿性乳腺炎“的中医诊断。
15	6.2	杨丽华	厦门市中医院	病理是诊断 GLM 的“金标准"，建议空芯针穿刺活检。	取带脓腔边壁的组织诊断“肉芽肿性小叶性乳腺炎”的阳性率高。	未采纳，待进一步临床研究。 本次共识仅提出病理诊断的是ＧＬＭ的金标准，具体的取材方法及取材时间的选择未详细描述，需进一步研究
16	6.2	樊凤英	江苏省中西医结合医院	1.病理是诊断 GLM 的“金标准”，但不应该要求所有患者做穿刺病理检查	1.临床根据其特征性病史、临床症状及体征、检验及超声绝大多数应该能明确诊断。	采纳 已做更改。针对肉芽肿性乳腺炎，病理学诊断是金标准。但考虑为有创操作，所以在本共识中，提出肉芽肿性乳腺炎的临床诊断参考标准，并为大多数专家所接受，形成专家共识。

17	6.2	樊凤英	江苏省中西医结合医院	2.建议临床症状不典型，诊断有疑惑需经病理检查才能排除乳腺癌、特殊类型肉芽肿可能的患者，做穿刺病理检查。		未采纳，需后续临床进一步研究。 本次专家共识在治疗领域，尤其是具体的治疗方药方面暂未达成共识，需要进一步高水平的临床研究。
18	6.2	胡金辉	湖南中医药大学第一附属医院	建议空芯针穿刺活检		部分采纳。 针对肉芽肿性乳腺炎，病理学诊断是金标准。但考虑为有创操作，所以在本共识中，提出肉芽肿性乳腺炎的临床诊断参考标准，并为大多数专家所接受，形成专家共识。 “建议空苡针穿刺活检”主要与后一句“不建议行细针穿刺细胞学检查”对应。
19	6.2	郑春艳	湖北省中医院甲状腺乳腺外科	一定要有病理诊断		部分采纳。 共识文中已有体现，针对肉芽肿性乳腺炎，病理学诊断是金标准。但考虑为有创操作及部分患者拒绝接受，以及迁延后期难以取得典型的病理学标本，所以在本共识中，提出肉芽肿性乳腺炎的临床诊断参考标准，并为大多数专家所接受，形成专家共识。
20	6.2	钮晓红	南京中医药大学附属南京市中西医结合医院	6.2病理诊断应该放入临床诊断参考标准之中。	6.2 临床诊断参考标准 根据本病特征性临床表现，结合辅助检查等，建立 GLM 临床诊断参考标准，具体如下： 6.2.1 特征性病史	部分采纳 针对肉芽肿性乳腺炎，病理学诊断是金标准。但考虑为有创操作，包括部分患者拒绝接受，以及有可能在迁延期很少能够看到典型的病理表现，所以在本共识中，提出肉芽肿性乳腺炎的临床诊

					a)多为育龄期女性，近期有妊娠生育史； b)多有导管内乳汁淤积或异常泌乳相关因素（如高泌乳素血症或药物相关性泌乳）； 6.2.2 临床症状及体征 a)短期内出现的疼痛性肿块，多外周起病，进展迅速，可波及乳头乳晕后方，甚则全乳；脓成不畅，成脓后易侵袭皮肤，形成多发窦道；坚肿难消，易反复发作； b)可有乳腺外表现，如结节性红斑、关节疼痛、发热、皮疹等； 6.2.3 检验检查 a)病情进展或反复时炎性指标可升高； b)超声检查可见边界不清、形态不规则的低无回声病灶，成脓时内可见运动的细小点状回声（脓肿），不同病变间可出现相连续的条状低无回声区(窦道)；病变区可延伸至皮下或乳房后间隙；病灶或边缘常可见较丰富的血流信号。 c)排除如异物肉芽肿、结核性肉芽肿和Wegener肉芽肿等其他慢性炎性病变。	断参考标准，以为将来的临床研究提供参考依据，并为大多数专家所接受，形成专家共识。

					6.2.4 病理诊断 病理是诊断 GLM 的“金标准”，建议空芯针穿刺活检,不建议行细针穿刺细胞学检查。病理特征性表现为：以乳腺小叶为中心的非干酪样坏死性肉芽肿形成，伴有上皮样细胞、多核巨细胞及以中性粒细胞为主的炎症细胞浸润，可见多发微脓肿和脂肪坏死。 符合 2、4 两条即可确诊。	
21	6.3.1	张晓军	中国中医科学院西苑医院	补充特征性病史内容	加上乳头内陷（乳腺导管发育异常）	未采纳 需后续临床进一步研究。本次专家咨询并未达成一致共识。
22	6.3.2	王宽宇	黑龙江中医药大学附属第一医院	原为“短期内出现的疼痛性肿块”	短期内出现的肿块，可伴有疼痛”	部分采纳 专家咨询及专家共识会议就大部分专家认为肉芽肿性乳腺炎肿块的表现特点多伴有疼痛
23	6.3.2	罗明	中山市中医院	形成多发脓肿及窦道		部分采纳 共识中有类似表述，窦道的形成意味着有脓肿的发生在前。
24	6.3.3	张晓军	中国中医科学院西苑医院	增加检验检查项目	包含乳腺磁共振检查	未采纳 需后续临床进一步研究。考虑疾病的进展状况及核磁共振的费用，本共识中专家组未强烈推荐 MR 做为必需的检查手段，但临床可根据具体需求进行选择。
25	6.3.3	谢丹	广州中医药大学第一附	建议将“c)排除如异		未采纳 限于篇幅，仅对临床常见的非哺乳期乳腺炎与乳

			属医院	物肉芽肿、结核性肉芽肿和 Wegener 肉芽肿等其他慢性炎性病变。”的内容整合到鉴别诊断中。		腺恶性肿瘤进行鉴别。
26	6.3.3	吴祖培	广州中医药大学顺德医院	检验检查增加脓液细菌培养		未采纳 需后续临床进一步研究。ＧＬＭ目前有研究认为本病与棒状杆菌的感染相关，但尚未达成共识，且抗生素治疗的效果并不理想，本草案主要形成中医专家诊疗共识，未就现代医学的治疗形成更多意见，有待更多临床研究及数据。
27	6.4	樊英怡	北京中医药大学第三附属医院	孕期或哺乳期的肉芽肿，如何和化脓性急性乳腺炎鉴别		未采纳 限于篇幅，仅对临床常见的非哺乳期乳腺炎与乳腺恶性肿瘤进行鉴别。
28	6.4.2	罗明	中山市中医院	本病亦可分离出类分枝杆菌		未采纳，待临床进一步研究； 本病在部分患者培养可以见棒状杆菌生长，但未达成专家共识，需进一步研究
29	6.4.3	张晓军	中国中医科学院西苑医院	乳头内陷或开口畸形不适宜作为肉芽肿性小叶性乳腺炎与乳晕下脓肿的鉴别诊断		未采纳，需后续临床进一步研究。 本次专家咨询基本达成一致，乳头内陷是乳晕下脓肿的主要临床表现，二者鉴别还需增加其它鉴别要点。
30	6.4.4	程亦勤	上海中医药	多数人认为导管周	依据第③条攥写思路，建议第④条	未采纳

			大学附属龙华医院	围炎与导管扩张症、浆细胞性乳腺炎是同一疾病的不同阶段 ：③慢性炎症反应期：病灶中可见大量淋巴细胞、浆细胞、组织细胞浸润，此期常被称为浆细胞性乳腺炎；④肉芽肿形成期：可形成假结核样肉芽肿；	改成：肉芽肿形成期：可形成假结核样肉芽肿，此期常被称为肉芽肿性乳腺炎	目前专家咨询及病理学研究暂未达成此项共识。
31	6.4.5	罗明	中山市中医院	建议增加跟急性乳腺炎的鉴别诊断		未采纳 限于篇幅，仅对临床常见的非哺乳期乳腺炎与乳腺恶性肿瘤进行鉴别。
32	6.5	郑春艳	湖北省中医院甲状腺乳腺外科	肿块型和脓肿型分型混合存在		采纳 共识中已有体现，本共识专家投票建议根据疮疡三期分型，分为“肿块型 / 脓肿型 / 溃后型 "，另外结合本病的特点，增加了“多型并存型”。
33	6.5	赵虹	浙江中医药大学附属第一医院（浙江省中医院）	不建议按病程时间分急性期、亚急性期、迁延期		未采纳，待进一步的临床研究。 本病有一定的自限性，判断是否痊愈或临床治愈很难评价一部分治疗方案，所以治疗时长是很重要的一个评价维度。但患者就诊时所处的临床分期，如急性期或迁延期对病程的定义有很大影响。所以专家对此形成共识，根据临床分期进行分层分析，可以更好的指导和评价临床试验。

34	6.5.1	罗明	中山市中医院	增加说明，本病有部分患者各期可同时存在。		采纳 共识中已有体现，本共识专家投票建议根据疮疡三期分型，分为“肿块型／脓肿型／溃后型"，另外结合本病的特点，增加了“多型并存型”，具体治疗时依主要表现进行相关处理。
35	6.5.1	薛晓红	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	急性期 3 个月时间过长	本病一般 30-50 天成脓	未采纳 专家咨询及专家共识会议就此分型进行讨论，认为此型为肉芽肿性乳腺炎疾病前 3 个月疾病进展更明显，易于出现全身性炎性反应，所以参考本病的自然病程，定义为“多见于疾病前 3 个月”，并不是一定要满 3 个月。
36	6.5.2	程旭锋	河南中医药大学第一附属医院	修改临床分型“溃后型”	临床分型“溃破型”	未采纳，需后续临床进一步研究。 肉芽肿性乳腺炎临床易溃破，但不是必须溃破，与正确的治疗有很大的关系。溃后更多是明确脓肿排出后的一种状态。
37	6.5.2	张晓军	中国中医科学院西苑医院	删除 d)多型并存型	段末加述“临床常以多型并存出现，注意辨证施治、临证加减。”	未采纳。 专家咨询及专家共识会议就此分型进行讨论，认为此型为肉芽肿性乳腺炎的特殊表现，治疗时依据主要表现即可。
38	6.5.2	孙贻安	山东中医药大学附属医院	根据临床表现分型：肿块型和脓肿型。疾病初始阶段，往往肿块和脓肿并存，故难以单独定型。		采纳 共识中已有体现。本共识专家投票建议根据疮疡三期分型，分为“肿块型／脓肿型／溃后型"，另外结合本病的特点，增加了“多型并存型”，具体治疗时依主要表现进行相关处理。
39	6.5.2	程旭锋	河南中医药	临床分型建议去除	肿块型、脓肿型、溃后型	未采纳。

			大学第一附属医院	“多型并存型”型		专家咨询及专家共识会议就此分型进行讨论，认为此型为肉芽肿性乳腺炎的特殊表现，治疗时依据主要表现即可。
40	6.5.2	霍艳丹	四川省第二中医医院	修改溃后型		未采纳 需待临床进一步研究。本病确实有部分患者未有溃破史，但窦道的形成也往往在疾病的脓肿期时可伴见，所以单列窦道型亦很难区分。 本共识专家投票建议根据疮疡三期分型，分为“肿块型／脓肿型／溃后型"，另外结合本病的特点，增加了“多型并存型”。
41	6.5.2	李智	西安市中医医院	肿块型	可否改成无波动感	未采纳 本次共识专家意见主要根据疮疡三期辨证分为“肿块型，脓肿型，溃后型”进行分型。
42	6.5.3	赵立娜	北京中医药大学东方医院	乳房虽通常分为四个象限，但临床评价病灶范围还要考虑乳头乳晕中央区，及近腋窝的乳房腋尾部	建议明确定义象限及分区的划分有利于病变范围的归类。	部分采纳 在前期的专家咨询过程中，就肿块的范围描述进行过相关的讨论，目前的描述有利于临床简单的划分。
43	7	赵虹	浙江中医药大学附属第一医院（浙江省中医院）	对于激素使用这块内容，是否可以减少		采纳 已在本共识中体现。因ＧＬＭ为中医优势病仲，本共识主要以中医诊疗内容为主，激素抗生素等治疗文中较少体现。
44	7	程旭锋	河南中医药大学第一附属医院	建议明确手术指征		未采纳 需后续临床进一步研究，手术是治疗肉芽肿性乳腺炎的一种方式，本次专家共识，更多专家认为

						本病通过中医药内外合治的方法，可以更好地保留乳房的外形，避免手术治疗。
45	8	赵虹	浙江中医药大学附属第一医院（浙江省中医院）	对于病理诊断穿刺活检的重要性要多重视，甚至半年以上的治疗如果效果不明显还需多次病理活检		部分采纳 已在文中强调了病理学为ＧＬＭ诊断的金标准，即避免漏诊和误诊乳腺恶性肿瘤。
46	8.2	程旭锋	河南中医药大学第一附属医院	建议更多考虑中医外科“阴阳辩证”		采纳 专家共识中已做参考，首辨阴疮阳疮，本病从阴阳辨证角度更多考虑是半阴半阳症。 本次专家共识更多建议以疮疡三期辨证做为基础，每一型也包括了阴阳辨证。
47	8.2	程旭锋	河南中医药大学第一附属医院	建议统一附用药加减辩证		未采纳，需后续临床进一步研究。 本次专家共识在治疗领域，尤其是具体的治疗方药方面暂未达成共识，需要进一步高水平的临床研究。
48	8.2	王丽	内蒙古自治区中医医院	建议加并发症的中医治疗如：结节性红斑的中医治疗		未采纳，需后续临床进一步研究。 本次专家共识主要在 GLM 的诊断及疗效评价标准，以及在疾病的分型分期以及分类治疗领域达成了一定共识。在治疗领域，尤其是具体的治疗方药方面暂未达成共识，需要进一步高水平的临床研究。
49	8.2	薛晓红	上海中医药大学附属岳	内治法不同期各有一不同主方欠妥	临床在某一治疗原则下据疾病不同阶段适当加减	未采纳，需后续临床进一步研究。 本次专家共识在治疗领域，尤其是具体的治疗方

			阳中西医结合医院			药方面暂未达成共识，需要进一步高水平的临床研究。
50	8.2	薛晓红	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	中医辨证分型有待补充		未采纳，需后续临床进一步研究。 本次专家共识在治疗领域，尤其是具体的治疗方药方面暂未达成共识，需要进一步高水平的临床研究。
51	8.2	蒋孜明	玉林市中医医院	1：黄芪竹叶汤。津虚明显时。		未采纳，需后续临床进一步研究。 本次专家共识在治疗领域，尤其是具体的治疗方药方面，从六经辨证或是脏腑辨证，暂未达成共识，需要进一步高水平的临床研究。
52	8.2	蒋孜明	玉林市中医医院	2：黄芪竹叶黄芩汤，基本方。		未采纳，需后续临床进一步研究。 本次专家共识在治疗领域，尤其是具体的治疗方药方面，从六经辨证或是脏腑辨证，暂未达成共识，需要进一步高水平的临床研究。
53	8.2	蒋孜明	玉林市中医医院	分型的目的是为了治疗，内治法，应该是辩证分型。		未采纳，需后续临床进一步研究。 本次专家共识在治疗领域，尤其是具体的治疗方药方面，从六经辨证或是脏腑辨证，暂未达成共识，需要进一步高水平的临床研究。
54	8.2.2	程旭锋	河南中医药大学第一附属医院	内治法脓肿型建议去除“益气托毒”		暂保留，需后续临床进一步研究。 专家咨询及共识会议认为肉芽肿性乳腺炎脓成不畅，加用益气法有助于脓肿透畅排出，缩短病程
55	8.2.3	程旭锋	河南中医药大学第一附属医院	内治法溃后型建议去除“益气健脾”		未采纳，需后续临床进一步研究。 专家咨询及共识会议认为肉芽肿性乳腺炎患者临床上往往经过多种治疗，如长程激素及抗生素治疗等，伤及脾胃，可暂保留。

56	8.3 外治法	李湘奇	山东第一医科大学第二附属医院	增加乳房部分腺体切除术	增加乳房部分腺体切除术：病变累及 1-2 个象限或多发脓肿	未采纳，需后续临床进一步研究。 手术是治疗肉芽肿性乳腺炎的一种方式，本次专家共识，更多专家认为本病通过中医药内外合治的方法，可以更好地保留乳房的外形，避免手术治疗。
57	8.3 外治法	李湘奇	山东第一医科大学第二附属医院	增加全乳房切除或皮下腺体切除术	增加全乳房切除或皮下腺体切除术：病变累及 3 个以上象限	未采纳，需后续临床进一步研究。 手术是治疗肉芽肿性乳腺炎的一种方式，本次专家共识，更多专家认为本病通过中医药内外合治的方法，可以更好地保留乳房的外形，避免手术治疗。
58	8.3 外治法	孙贻安	山东中医药大学附属医院	每种治法建议详述操作规范，技术要点，方便推广		未采纳，需后续临床进一步研究。 本次专家共识在治疗领域，尤其是具体的治疗方药方面暂未达成共识，需要进一步高水平的临床研究。
59	8.3	贾建东	天津中医药大学第一附属医院	外治法是否可以加入搔爬、蚕食清创		未采纳，需后续临床进一步研究。 在共识中的“祛腐清创术“中包含了搔爬 / 蚕食清创的理念。将来在进一步规范或定义术语内容时再行修改。
60	8.3	李智	西安市中医医院	外治法中外敷药物可否加上“铁箍软膏”的应用		未采纳，需后续临床进一步研究。 本次专家共识在治疗领域，尤其是具体的治疗方药方面，从六经辨证或是脏腑辨证，暂未达成共识，需要进一步高水平的临床研究
61	8.3	罗明	中山市中医院	建议增加窦道拔罐疗法		未采纳，需后续临床进一步研究。 本次专家共识在治疗领域，尤其是具体的治疗方药及外治法手段，暂未达成共识，需要进一步高水平的临床研究

62	8.3 g)	霍艳丹	四川省第二中医医院	刺络放血术：刺络放血是为用冷针，而盘龙火针+拔罐方法可以有效应用于迁延期		未采纳，有待临床进一步研究。
63	9.1	钮晓红	南京中医药大学附属南京市中西医结合医院	(1) 临床治愈：术语定义有待商榷，以后在临床或科研工作中会存在歧议	a.痊愈临床症状消失，原炎性病灶临床上不可触及，溃疡或疮口愈合，即达到影像学治愈(CRR:complete radiological remission，影像学检查提示无病灶残留)维持半年无复发。 b.显效 临床症状消失，原炎性病灶临床上不可触及，溃疡或疮口愈合，即影像学不完全缓解(IRR:incomplete radiological remission)：影像学仍可见散在微小病灶。	部分采纳，需后续临床进一步研究。 因本病有一定的自限性，本次专家咨询及共识经过多轮的讨论，将临床结局分为临床治愈及影像学治愈（痊愈），以为疾病病程的判断建立依据。
64	9.1	张晓军	中国中医科学院西苑医院	术语指代不明；e 项 GMDAI 与其他 abcd 四项无太大关联	标题改为“预后转归及相关定义”，并把 e 项单列	部分采纳。 本段术语主要为后面 9.2.1“疾病转归”中的描述进行定义。
65	9.1	张晓军	中国中医科学院西苑医院	建议“b 痊愈”可直接定义为“影像学治愈”	“影像学治愈”	部分采纳。 “痊愈”与“临床治愈”分类方法参考了结核病的疗效判定标准。 术语中对“痊愈”进行了定义，即为影像学治愈。

66	9.1 e	孙贻安	山东中医药大学附属医院	疾病活动指数	建议增加部分血液指标：血沉、降钙素原、泌乳素等	未采纳，需后续临床进一步研究。 关于 GMDAI 中增加血液学指标，在前期的研究中血液学指标出现明显 的改变主要是 在急性期会有所表示，而疾病进入亚急性期或致迁延期时，血液学指标的变化不明显，会影响疗效评价的敏感性。 所以建议血液学检查单列进行评价，不放置在量表中作为评价条目
67	9.1 表 1	霍艳丹	四川省第二中医医院	肉芽肿性小叶性乳腺炎疾病活动指数	肿块占据象限范围可考虑作为评分依据；红、热范围建议作为评分依据；溃口数量建议参考作为评分依据	部分采纳，有待临床进一步研究。 本共识中关于肿块范围，认为是影响预后的较大变量，故在临床分型中单独进行分类，单纯型与弥漫型。 以便于临床进行分层分析；此外关于乳房溃口，本次ＧＭＤＡＩ在条目筛选及赋分上进行了相关临床研究。溃口的加入，因其治疗过程中短期内变化不敏感，对疗效的判定会产生较大影响，故研究后进行舍弃。
68	9.2.1	钮晓红	南京中医药大学附属南京市中西医结合医院		9.2.1　疾病转归 （1）痊愈 临床症状消失，原炎性病灶临床上不可触及，溃疡或疮口愈合，即达到影像学治愈(CRR:complete radiological remission，影像学检查提示无病灶残留)维持半年无复发。	部分采纳，需后续临床进一步研究。 关于 GMDAI 下降程度，在本次的共识当中，将其分为三级：高活动度，中活动度，低活动度，能下降一个级别即定义为有效。

					（2）显效 临床症状消失，原炎性病灶临床上不可触及，溃疡或疮口愈合，即影像学不完全缓解(IRR:incomplete radiological remission)：影像学仍可见散在微小病灶。 （3）有效（RT: responsive to treatment ；包括 IRR+CRR）：临床症状好转，GLM 疾病活动指数（ GMDAI）下降。 无效（URT: unresponsive to treatment：patients with radiologically progressive or stable）：临床症状无缓解，影像学提示对治疗无反应（稳定或病变范围扩大），GLM 疾病活动指数（ GMDAI）不变或增加。	
69	9.2.1	张晓军	中国中医科学院西苑医院	建议改为“疗效评价”，并删减“（1）治愈”，保留“有效、无效”	疾病转归改为“疗效评价”	未采纳，需后续进一步临床研究。 肉芽肿性乳腺炎现无公认的疗效评价标准，本专家共识就疗效评价的维度，包括治疗时长，乳房外形，治疗转归等都予以定义，以期为临床开展

						进一步的研究提供依据。
70	9.2.1	谢丹	广州中医药大学第一附属医院	建议在界定治疗有效时，GLM 疾病活动指数（ GMDAI）要下降超过一定的分值，而不是只要下降就评定为有效。		未采纳，需后续临床进一步研究 关于 GMDAI 下降程度，在本次的共识当中，将其分为三级：高活动度，中活动度，低活动度，能下降一个级别即定义为有效。
71	10	官卓娅	浙江省台州市路桥区中医院	在疾病恢复期，不单单是乳房病灶的恢复，患者体质恢复也是非常关键	能否加入根据患者体质辨识进行体质纠偏	未采纳 尚未达成专家共识，需后续临床进一步研究
72	10	任晓梅	江苏省中医院	修改内容	段末改为“须保持乳头乳晕清洁卫生，做到饮食有节，保持正常体重，起居适宜，劳逸结合，情绪调畅”	未采纳，需进一步临床研究。 关于乳头乳晕的清洁卫生及体重与本病之间的关系，尚需进一步的验证。
73	表 1GMDAI	张晓军	中国中医科学院西苑医院	溃口评分	可加范围大小、破溃处数	未采纳。 本共识中关于疗效评价中“ＧＭＤＡＩ＂条目的筛选及赋分进行了临床研究，溃口数目的多少/范围大小的加入，因其治疗过程中短期内变化不敏感，对疗效的判定产生影响，故没有进行更细化的描述。
74		李智	西安市中医医院	能否加上患者乳房重量较健侧增加		未采纳 本次共识专家意见对乳房重量的评价未达成一致。共识文中相应描述体现在ＧＭＤＡＩ中关于

						肿块的描述。
75		黄婉文	佛山市中医院	建议《专家共识》正式发表		采纳 正在收集专家意见，希望早日发表，为临床提供参考。
76	附录	罗明	中山市中医院	建议增加附录 B 常用方剂列表		未采纳，需后续临床进一步研究。 本次专家共识在治疗领域，尤其是具体的治疗方药方面，从六经辨证或是脏腑辨证，暂未达成共识，需要进一步高水平的临床研究

（注：上述说明附在本表的最后一页下面）

5.如果需要汇总的意见较多，可以从第 2 页起以“意见汇总及处理情况”下一行作为表头继续填写

说明：1.发送“征求意见稿”的专家 44 名；

2.收到“征求意见稿”后，回函的专家 33 名；

3.收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的专家 26 名；

4.没收回函的专家 11 名。